

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061875-71.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE  
**RECORRENTE:** GEANE DE OLIVEIRA DA SILVA BELFORD  
**RECORRENTE:** MICHEL DE OLIVEIRA BELFORT PECANHA  
**RECORRIDO:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**RECORRIDO:** MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO  
**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMETO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. TUTELA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO REFORMADA.**

**ACÓRDÃO**

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER dos recurso e DAR-LHE provimento para, na forma do art. 300 do CPC, para para determinar que os réus forneçam à parte autora o medicamento SOMATROPINA 4UI/mL, no prazo de 15 dias, conforme receituário acostado aos autos. Direciono à UNIÃO o cumprimento da referida obrigação, por se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS no âmbito do SMS/RJ, resguardada a possibilidade de ressarcimento em desfavor dos demais entes réus, ante a responsabilidade solidária das entidades federativas no presente caso. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2024.

5061875-71.2024.4.02.5101

510014278116 .V3

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061875-71.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE  
**RECORRENTE:** GEANE DE OLIVEIRA DA SILVA BELFORD  
**RECORRENTE:** MICHEL DE OLIVEIRA BELFORT PECANHA  
**RECORRIDO:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**RECORRIDO:** MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO  
**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RELATÓRIO**

Trata-se de medida de urgência, interposta pela parte autora, em face da decisão do Evento 3 dos autos originários, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que objetiva o fornecimento do medicamento SOMATROPINA 4UI/mL, na dose de 0,8 mL, subcutâneo, diariamente.

Aduz que o autor/ recorrente, menor impúbere, em acompanhamento junto ao Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - IPPMG, com baixa estatura grave, baixa velocidade de crescimento e idade óssea atrasada, apresentou teste de estímulo com insulina responsivo para GH, com diagnóstico de **nascido pequeno para idade gestacional** e não apresentou recuperação do crescimento, evoluindo com baixa estatura para a idade e abaixo do alvo genético.

Contrarrazões foram apresentadas pela União em evento 25.

É o relatório. Passo a decidir.

**VOTO**

## DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL

O art. 196, da CF/88, norma de aplicabilidade plena, declara o direito à saúde: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, ainda que as ações e serviços públicos de saúde sejam informados pela descentralização, conforme a norma constitucional inscrita no art. 198, I, da CRFB (e repetida no art. 7º, IX, da Lei n.º 8.080/1990), certo é que a própria Carta Magna estabelece uma competência concorrente (art. 24, XII) entre os entes constitutivos da federação para legislar sobre o assunto, bem como a competência material comum aos mesmos para realizar as ações correspondentes.

Tanto assim que a Lei n.º 8.080/1990 discrimina as competências da União Federal em seu artigo 16. Acrescente-se que, no que toca ao financiamento dos serviços de saúde, a União Federal tem participação direta, ainda que os serviços sejam prestados prioritariamente pelos Estados e Municípios.

A Portaria nº 3.916/MS/GM, de 30 de outubro de 1998 prevê a RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, de responsabilidade do Ministério da Saúde e prevê, igualmente a gestão do SUS pelos três níveis de governo, de modo a se promover um fornecimento de remédios racionalizado, padronizado e eficiente.

Desse modo, não é possível o argumento de que a Constituição ou mesmo sua lei integradora tenham querido limitar o acesso à rede pública de saúde ou às ações de saúde. A melhor interpretação é justamente a contrária. Deve ser amplo o atendimento, independentemente da correspondência federativa da entidade pública procurada ou das atribuições administrativas de cada ente político.

Assim, a divisão de responsabilidades entre União, Estado e Município não pode vincular a atuação do SUS frente ao administrado, que depende do Poder Público para garantir o seu direito à saúde.

Por outro lado, a solidariedade no campo assistencial do SUS sempre proporcionará ao ente obrigado judicialmente ao desembolso de valores, a possibilidade de ressarcimento ou compensação administrativa junto aos demais. As ações do SUS dependem de uma atuação coordenada dos entes públicos envolvidos na sua organização.

No que toca ao fornecimento de remédios, a União Federal tem responsabilidade sobre o Financiamento da Assistência farmacêutica Básica, nos termos da Portaria nº 2.084/GM de 26 de outubro de 2005, repassando para os Estados e Municípios a verba para a compra dos medicamentos para Atenção Básica.

Logo, a União tem competência não só para traçar regras gerais a serem cumpridas no SUS, como também para promover, quando necessário, a devida assistência in concreto. Os mecanismos de compensação dos entes que atuam no SUS - União, Estados e Municípios - não podem impedir a prestação positiva do Estado.

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado 43 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

***Enunciado 43: “A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS.”***

Neste sentido, confira-se recente jurisprudência do STF, que ratifica seu posicionamento acerca da solidariedade dos entes públicos no fornecimento de medicamentos, nos seguintes termos:

*DECISÃO: Vistos. União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Espírito Santo, que manteve a decisão do juízo monocrático, que indeferiu o chamamento da União para integrar o polo passivo de demanda em que se discute fornecimento de medicamentos. Opostos embargos de declaração (fls. 219/220), foram rejeitados (fls. 223/224). Alega o recorrente violação dos artigos 37, caput, e 198, inciso I, da Constituição Federal. Contra-arrazado (fls. 241 a 247), o recurso extraordinário (fls. 229 a 230) foi admitido (fl. 249). Decido. Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. Não merece prosperar a irresignação. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia*

sobre legitimidade passiva da União em ação em que se discute a obrigação de fornecer medicamentos, em harmonia com a jurisprudência desta Corte que, no julgamento do RE nº 808.059/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe de 1º/2/11), fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária. Nesse sentido, também, as recentes decisões monocráticas: AI nº 817.241/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 14/10/10; RE nº 839.594/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/3/11, e AI nº 732.582/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17/3/11. Sobre o tema, ainda, anote-se o seguinte precedente: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. **MEDIDA** PROTETÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se **medida** meramente protetória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/11) Diga-se, por fim, que nos autos do RE nº 566.471, Relator o Ministro Marco Aurélio, discute-se a possibilidade de condenação de Estados ou municípios ao custeio de medicamentos que não integram a lista daqueles fornecidos gratuitamente pelo sistema de saúde pública. Essa matéria, portanto, não se confunde

No mesmo sentido, o STJ, recentemente, pacificou seu entendimento na Primeira

Seção:

*PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*

1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção firmaram o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.

2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos Recursos Especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça, mas de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 110.184/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 30/10/12 e AgRg no REsp. 1.267.702/SC, Quinta Turma, Rel.

Min. JORGE MUSSI, DJe 26/9/11, AgRg no REsp. 1.334.109/SC, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 25.06.2013.

3. Agravo Regimental do Município de Belo Horizonte desprovido.

(AgRg no AREsp 325.781/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014)

com a do presente recurso extraordinário, que trata do chamamento da União ao processo e da eventual responsabilidade solidária dos entes da Federação. Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se (STF, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, RE 668603 / ES, data do julgamento: 26/04/2013).

## **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE**

As atribuições relativas à assistência farmacêutica no campo da saúde pública, englobam as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização – compreendidas a prescrição e a dispensação – de medicamentos (artigos 16, X; 17, VIII; e 18, V, da Lei n. 8.080/1990 e item 3.3 da Portaria MS n. 3.916, de 30 de outubro de 1998 – Política Nacional de Medicamentos). O Decreto nº 7.508/11 recentemente deu nova regulamentação à Lei 8.080/80, não alterando a linha da descentralização.

Em toda hierarquização e descentralização quanto ao fornecimento direto de medicamentos e demais insumos respectivos, fica claro que: (i) cabem ao gestor municipal as responsabilidades para definição dos medicamentos essenciais e para o seu abastecimento. Ou seja, os medicamentos fornecidos pelo município são aqueles considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população; (ii) compete aos Estados federados a dispensação de medicamentos de ordem excepcional, ou seja, medicamentos utilizados em doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja compra e disponibilização atende

a casos específicos; (iii) por fim, quanto à União Federal, é conferida pela Política Nacional de Medicamentos a responsabilidade em adquirir e distribuir produtos em situações especiais considerando três pressupostos básicos, de ordem epidemiológica, a saber: a) doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou põem em risco a coletividade, e cuja estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores; b) doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com o uso de medicamentos de custos elevados; c) doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no mercado.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a competência da União no fornecimento de medicamentos, conforme farta regulamentação, se refere aos: a) medicamentos de interesse em saúde pública: aqueles utilizados no controle de doenças que, em determinada comunidade, têm magnitude, transcendência ou vulnerabilidade relevante e cuja estratégia básica de combate é o tratamento dos doentes; e b) medicamentos de uso contínuo: são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas, utilizados continuamente, sendo que em ambos os casos, só serão fornecidos pela União aqueles que se encaixarem no perfil estratégico concernente à definição de sua esfera de responsabilidade. Com base nessa divisão de responsabilidades, delimita-se a competência da Justiça Federal e consequentemente dos Juizados Especiais Federais para apreciar as ações que objetivam o fornecimento de medicamentos, atendo-se somente àquelas em que a dispensação de medicamentos caiba à União Federal.

Na mesma linha da argumentação acima, segue parte da jurisprudência do STJ e também a jurisprudência pacífica do TRF da 2ª Região, conforme, com grifos nossos:

*“SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL.*

*I - A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela ilegitimidade da União para figurar em ação para fornecimento gratuito de medicamentos.*

*II - A competência da União está adstrita à gestão federal do SUS, repassando os recursos financeiros, cabendo então aos Municípios e, supletivamente, aos Estados, a aquisição e a adequada dispensação de medicamentos. Precedente: (AgRg no REsp nº 888.975/RS, Relator p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 22.10.2007).*

*III - Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no Ag 879.975/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Dje 14/04/2008)*

*“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A sentença, também condicionada a reexame necessário, ratificando a decisão antecipatória, condenou somente a União a fornecer ao autor, portador de esquizofrenia psicótica, os medicamentos Losartana Potássica 100mg/dia; Pimozida 04 mg/dia; Flurazepan 30 mg/dia, e Dicloridrato de Manidipin, disponibilizando quantidade suficiente para o tratamento no período de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com a necessidade diária prescrita nos laudos médicos..., nas quantidades mensais especificadas com base nos receituários..., devendo o Autor apresentar, a cada 06 (seis) meses, receituário atualizado, comprovando a necessidade de uso continuado dos referidos medicamentos. 2. A União Federal, em regra, no âmbito do SUS, não tem atribuição de distribuir diretamente medicamentos, do que decorre a sua ilegitimidade passiva para responder ações movidas para obtê-los. Inteligência da Lei nº 8.080/90. Precedentes da Turma. 3. A remessa dos autos à Justiça Estadual, melhor ajustada à sistemática do SUS, tem o efeito prático de aproximar os pacientes necessitados de assistência médico-farmacêutica dos organismos locais responsáveis, assim otimizando a efetividade das prestações demandadas. 4. Na hipótese, a parte autora, portadora de esquizofrenia psicótica, necessita de remédios não integrantes da lista de medicamentos excepcionalmente fornecidos pela União Federal, e dos autos não consta laudo médico categórico afirmativo da essencialidade dos medicamentos em causa, destacando-os como únicos e insubstituíveis para restabelecer a saúde do paciente, e situando-o, nessa medida, em quadro excepcional para justificar tratamento diferenciado, de sorte que se impõe a remessa do feito ao Estado. 5. Apelação da União Federal e Remessa Necessária providas. Apelação da parte autora e agravo retido prejudicados.”*

*(TRF2, APELRE 200951010132455, Desembargadora Federal NIZETE LOBATO CARMO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 22/01/2013.)*

*“AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO PÓLO PASSIVO. 1. Agravos internos contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a exclusão da União do pólo passivo da demanda na qual se pede a entrega de medicamentos, com a remessa dos autos ao Juízo estadual competente. 2. A asseveração de solidariedade apenas significa que os entes federativos dos três níveis têm o dever de compor o sistema de saúde pública, na forma delineada pela Constituição Federal e especificada pela legislação infraconstitucional. Assim, ela é insuficiente para fazer com que se possa litigar ou não contra a União Federal, em casos nos quais não existe, na distribuição interna das competências, dever da União de comprar ou fornecer o remédio específico. 3. Agravos internos não providos.” (TRF2, AG 201202010183666, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 17/12/2012.)*

*ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA DO ESTADO.*

*Em regra, não é pertinente a inserção da UNIÃO FEDERAL no pólo passivo de pleito em que se objetiva obter remédios. A atuação da União Federal, no âmbito do problema relativo a medicamentos, não é a de comprá-los e de distribuí-los, diretamente. O Sistema Único de Saúde objetiva coordenar os recursos e práticas ligadas à saúde pública, de modo a dividir atribuições e obter eficiência. Não cabe à União a compra e a entrega direta de medicamentos, salvo os casos*

especiais previstos na divisão de atribuições. Assim, exclui-se da lide a União Federal e, com fulcro no artigo 113 do CPC, pronuncia-se a nulidade da sentença, determinada a remessa dos autos à Justiça do Estado, para que lá tudo seja apreciado. Remessa (conhecida de ofício) e apelação da UNIÃO FEDERAL providas. Prejudicado o apelo do Estado do Rio de Janeiro. ( TRF2 - AG 201202010107937, Rel. p/acórdão GUILHERME COUTO, E-DJF2R - Data::26/09/2012.)

*"PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.*

1. Conquanto a apreciação do agravo retido interposto pela União não tenha sido requerida em sua apelação (art. 523, § 1º, do CPC), o recurso poderia ser conhecido por força da remessa necessária. Todavia, não o será porquanto se insurge contra o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e porque a ilegitimidade passiva suscitada é reiterada nas razões de apelação.

2. A aquisição e distribuição dos medicamentos para combater a doença que acomete a autora (glaucoma) inserem-se entre as atribuições do Estado e do Município (art. 9º, §1º, inciso II, da Portaria nº 288/ SAS, de 19 de maio de 2008). Desprezar a repartição de atribuições, prevista na Lei nº 8.080/90 (artigos 16 a 19) e demais normas que regulamentam o funcionamento do SUS, torna o sistema ineficiente e dispendioso, notadamente em vista de condenações solidárias dos entes ao fornecimento dos mais variados medicamentos. A União não tem a incumbência de adquiri-los e distribuí-los, pois os medicamentos pleiteados não estão listados na Portaria nº 2.981/2009. Reconhecida a ilegitimidade da União e, portanto, a incompetência da Justiça Federal, deve ser declarada a nulidade da sentença e encaminhado o processo à Justiça Estadual (art. 113, § 2º, do CPC).

3. Agravo retido da União não conhecido e remessa e apelação da União providas. Prejudicados os recursos dos demais réus." (grifou-se e destacou-se).

(TRF2, AC 200851010252432, Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 08/03/2013)

## **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO PADRONIZADOS**

Após longo debate, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.657.156/RJ entendeu que é de obrigação do poder público fornecer medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que os satisfeitos todos os requisitos, conforme o entendimento a seguir:

*"EMENTA ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.*

1. Caso dos autos: (...) 2. Alegações da recorrente:(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015." STJ - Resp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 04/05/2018(grifos e abreviações nossas).

Após análise dos autos, resta claro que a parte autora satisfaz os requisitos necessários para a concessão de medicamentos.

No caso em tela, a autora, menor impúbere, em acompanhamento junto ao Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - IPPMG, com baixa estatura grave, baixa velocidade de crescimento e idade óssea atrasada, apresentou teste de estímulo com insulina responsivo para GH, com diagnóstico de nascido **pequeno para idade gestacional** e não apresentou recuperação do crescimento, evoluindo com baixa estatura para a idade e abaixo do alvo genético.

No laudo médico, acostado aos autos originários (5058804-61.2024.4.02.5101), há indicação do medicamento SOMATROPINA 4UI/mL, na dose de 0,8 mL, subcutâneo, diariamente.

Apresentada a questão à Câmara de Resolução de Litígios em Saúde, foi emitido o Parecer Técnico CRLS Nº 105802/2024 de 16 de julho de 2024, no qual informa que o medicamento somatropina tem seu uso aprovado pela ANVISA para o tratamento da patologia

do assistido. Acrescenta-se que não há substituto terapêutico disponível no SUS para o tratamento da condição clínica que acomete o assistido. Veja-se:



CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE

Parecer Técnico CRLS Nº 105802/2024

Rio de Janeiro, 16 de July de 2024

Prezados(a),

O presente parecer visa informar a Defensoria o encaminhamento realizado acerca do(s) produto(s) pleiteado(s) pelo assistido MICHEL DE OLIVEIRA BELFORT PEÇANHA, os quais foi /foram analisado(s) pela(s) equipe(s) técnica(s) da SES e/ou SMS, resultando no seguinte encaminhamento/ parecer técnico:

| PRODUTO                        | ENCAMINHAMENTO |
|--------------------------------|----------------|
| SOMATROPINA 4UI/ml (Cod.:6205) | Defensoria     |

Cabe esclarecer que:

1 - O(s) produto(s) com encaminhamento para a Defensoria não se encontra(m) padronizado(s) em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Parecer Técnico Defensoria:

| PRODUTO                        | PARECER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOMATROPINA 4UI/ml (Cod.:6205) | <p>PARECER TÉCNICO SES/SJ/CRLS</p> <p>Rio de Janeiro, 16 de julho de 2024.</p> <p>Parecer<br/>acerca da solicitação de MICHEL DE OLIVEIRA BELFORT PEÇANHA</p> <p>Prezados,</p> <p>O presente parecer visa informar a Defensoria Publica acerca do encaminhamento do produto pleiteado pelo(a) assistido(a), MICHEL DE OLIVEIRA BELFORT PEÇANHA o qual foi analisado pela equipe técnica da CRLS, resultando no seguinte parecer técnico:</p> <p>PRODUTO: SOMATROPINA 4UI/ml<br/>POSOLOGIA: Aplicar 0,8ml, SC à noite<br/>DURAÇÃO DO TRATAMENTO: Uso contínuo</p> <p>DOCUMENTOS MÉDICOS ANALISADOS E QUADRO CLÍNICO DESCRITO:<br/>Para elaboração do presente parecer técnico foi considerado o laudo médico oriundo(s) de IPPMG UFRJ emitido em 20/02/2024. Segundo laudo médico trata-se de assistido de 11 anos, com baixa estatura grave, nascido pequeno para idade</p> |



#### CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE

gestacional (PIG), evoluindo com velocidade de crescimento e idade óssea atrasada, além de déficit intelectual leve.

##### DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS ACERCA DO MEDICAMENTO

Trata-se de assistido (a) com 11 anos e com diagnóstico de pequeno para idade gestacional. CID 10 (P05.1). Pleiteando o medicamento Somatropina.

A somatropina é indicada para crianças: no tratamento do distúrbio de crescimento em crianças devido à secreção insuficiente do hormônio de crescimento ou associado à síndrome de Turner.

##### DO REGISTRO NA ANVISA:

Em análise ao sistema de pesquisa de registro no site da ANVISA, informa-se que o medicamento Somatropina possui registro válido na ANVISA.

##### DA INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO EM CONFORMIDADE COM O REGISTRO NA ANVISA (BULA):

O medicamento somatropina tem seu uso aprovado pela ANVISA para o tratamento da patologia do(a) assistido(a).

##### PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DESCRITA:

O medicamento Somatropina faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica ? CEAF e possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico publicado pelo Ministério da Saúde para o manejo da doença hipopituitarismo e Síndrome de Turner. Acrescenta-se que não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico publicado pelo Ministério da Saúde para o manejo da doença pequeno para idade gestacional.

##### DA DISPONIBILIDADE DO MEDICAMENTO NO SUS

O medicamento Somatropina está enquadrado no grupo de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), grupo de Financiamento do CEAF 1A e desta forma é fornecido gratuitamente pelo governo para os pacientes que preenchem os critérios estabelecidos pelo PCDT. Instar informar que o medicamento pleiteado Somatropina é padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) através do



#### CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 02 (regras de financiamento e execução) e pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 06 (regras de financiamento, controle e monitoramento), ambas de 28 de setembro de 2017 e retificadas no Diário Oficial da União de 13 de abril de 2018. De acordo com a referida Portaria, a Classificação Estatística Internacional de Problemas e Doenças Relacionadas à Saúde (CID-10) configura um dos critérios estabelecidos para a dispensação dos medicamentos padronizados no CEAF.

Acrescenta-se, que no laudo o CID informado é P05.1, e para a dispensação da Somatropina pelo CEAF os CID's contemplados são: E23.0, Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4 e Q96.8.

Cabe destacar que em laudo médico preenchido pelo médico assistente foi relatado que este paciente se enquadra nos CASOS ESPECIAIS, último parágrafo do item 6 do PCDT (PORTARIA CONJUNTA Nº 28, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018) ?Pacientes nascidos pequenos para idade gestacional (PIG) e com síndromes genéticas com evidência de benefício do uso de GH devem ser avaliados em Centros de Referência ou por equipe técnica especializada?, desta forma, tem indicação de tratamento com hormônio de crescimento, a fim de se reduzir o déficit de crescimento associado ao quadro.

Acrescenta-se que não há substituto terapêutico disponível no SUS para o tratamento da condição clínica que acomete a assistida. Diante da falha na resolução administrativa do pleito, encaminhamos à Defensoria.

TATIANA SOARES SPRITZER  
MÉDICA/SES/SJ/CRLS  
CRM 52706256

2 - O(s) produto(s) relacionado(s), com encaminhamento para a Unidade de Saúde, consta(m) nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde para retirada do(s) mesmo(s) assistido(s) está encaminhado para a(s).

| PARECER | PRODUTO | RESPONSÁVEL - CARGO / EQUIPE |
|---------|---------|------------------------------|
|---------|---------|------------------------------|



Assim, da análise dos elementos coligidos aos autos, constato que o laudo médico apresentado nos autos originários (Evento 1, ANEXO2), comprova que o demandante necessita do uso do fármaco requerido, de forma urgente, certo de que a parte autora é pessoa hipossuficiente, não possuindo condições financeiras de suportar o tratamento recomendado para o seu mal, cabendo ao Estado providenciar o suporte necessário a tanto.

Nessa toada, verifico, a priori, a imprescindibilidade da medicação para o controle da enfermidade do menor, bem como o perigo de dano, considerando a natureza da doença e a idade do autor.

Ante o exposto, voto por **CONHECER dos recurso e DAR-LHE** provimento para, na forma do art. 300 do CPC, para para determinar que os réus forneçam à parte autora o medicamento SOMATROPINA 4UI/mL, no prazo de 15 dias, conforme receituário acostado aos autos. Direciono à UNIÃO o cumprimento da referida obrigação, por se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS no âmbito do SMS/RJ, resguardada a possibilidade de ressarcimento em desfavor dos demais entes réus, ante a responsabilidade solidária das entidades federativas no presente caso. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.